

Insomnio, hipersomnia y parasomnias

1. Introducción y relevancia clínica

El sueño es un **proceso fisiológico esencial** para la recuperación física y mental.

Los **trastornos del sueño** constituyen una causa frecuente de consulta en atención primaria y psiquiatría, y afectan significativamente la **calidad de vida, el rendimiento cognitivo y el estado emocional**.

En el adulto mayor, el sueño se vuelve **más fragmentado y superficial**, lo que predispone a alteraciones clínicas del ciclo sueño-vigilia.

Clasificación general (AASM / DSM-5)

1. **Insomnio** (dificultad para iniciar o mantener el sueño).
2. **Hipersomnias** (somnolencia diurna excesiva).
3. **Parasomnias** (conductas anormales durante el sueño).
4. **Trastornos del ritmo circadiano**.
5. **Trastornos respiratorios y del movimiento durante el sueño** (apnea, síndrome de piernas inquietas).

Importancia clínica

- 30–40% de la población general sufre síntomas de insomnio al menos una vez al año.
- Los trastornos del sueño **incrementan el riesgo de depresión, hipertensión, diabetes y deterioro cognitivo**.
- El MINSAL los reconoce como **problema prioritario de salud mental y bienestar en adultos mayores**.

□ En EUNACOM, suelen aparecer casos clínicos con **insomnio crónico, somnolencia diurna o terrores nocturnos**, donde se debe distinguir entre causas primarias, psiquiátricas o médicas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Regulación fisiológica del sueño

El sueño está regulado por dos procesos principales:

- **Proceso homeostático (S):** necesidad creciente de sueño a medida que pasa el tiempo despierto.
- **Proceso circadiano (C):** controlado por el **núcleo supraquiasmático del hipotálamo**, sincronizado con la luz solar.

Neurotransmisores implicados:

- **GABA:** principal inhibidor del sistema reticular activador → induce sueño.
 - **Serotonina, adenosina y melatonina:** facilitan inicio del sueño.
 - **Noradrenalina, dopamina e histamina:** promueven vigilia.
-

2.2. Estructura del sueño

El sueño normal se divide en:

- **Sueño No REM (N1, N2, N3):** sueño profundo, restaurador.
- **Sueño REM:** asociado a los sueños y consolidación de la memoria.

Un ciclo completo dura ~90 minutos, con 4–5 ciclos por noche.

Con la edad:

- ↓ sueño profundo (N3)
 - ↑ despertares nocturnos
 - ↓ latencia al sueño REM
-

2.3. Factores que alteran el sueño

- Estrés, ansiedad, depresión.
 - Dolor crónico, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o endocrinas.
 - Uso de cafeína, alcohol, nicotina o estimulantes.
 - Medicamentos: ISRS, corticoides, betabloqueadores, diuréticos.
 - Factores ambientales: ruido, luz, temperatura, turnos nocturnos.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Insomnio

Definición: dificultad para iniciar o mantener el sueño, o despertar precoz, con **repercusión diurna significativa** (fatiga, irritabilidad, déficit de atención).

Clasificación:

Tipo	Características
Insomnio de conciliación	Dificultad para quedarse dormido.
Insomnio de mantención	Despertares nocturnos frecuentes.
Despertar precoz	Sueño insuficiente y despertar antes de lo deseado.

Duración:

- **Agudo:** <3 meses (estresor identificable).
- **Crónico:** ≥3 noches por semana durante ≥3 meses.

Síntomas diurnos:

- Fatiga, somnolencia, baja concentración.
 - Irritabilidad, ansiedad o ánimo deprimido.
 - Disminución del rendimiento laboral o académico.
-

3.2. Hipersomnia

Definición: somnolencia excesiva diurna no explicada por privación de sueño.

Causas principales:

1. **Trastornos primarios del sueño:**

- **Narcolepsia:** ataques irresistibles de sueño, cataplejía, alucinaciones hipnagógicas.
- **Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS):** pausas respiratorias, ronquidos intensos, somnolencia matinal.

2. **Causas secundarias:**

- Uso de sedantes, benzodiazepinas, antidepresivos.
 - Trastornos depresivos o bipolares.
 - Hipotiroidismo o insuficiencia renal crónica.
-

3.3. Parasomnias

Definición: fenómenos motores o conductuales anormales durante el sueño.

Tipo	Características	Etapas del sueño
Sonambulismo	Deambulación durante sueño profundo, sin recuerdo posterior.	N3 (No REM)

Terrores nocturnos	Gritos, pánico intenso, taquicardia, sin recuerdo del episodio.	N3
Pesadillas	Sueños angustiantes con recuerdo vívido.	REM
Trastorno de conducta del sueño REM	Actuación de los sueños, movimientos violentos.	REM

☐ En adultos mayores, el **trastorno de conducta del sueño REM** puede ser **precursor de Parkinson o demencia de cuerpos de Lewy**.

3.4. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Claves diferenciales
Depresión mayor	Insomnio con despertar precoz, anhedonia.
Ansiedad generalizada	Dificultad para conciliar el sueño, pensamientos rumiantes.
Uso de estimulantes	Historia de consumo de café, nicotina o fármacos.
Apnea del sueño	Ronquidos, pausas respiratorias, somnolencia matutina.
Trastorno bipolar	Disminución de necesidad de sueño sin fatiga (fase maníaca).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

Basado en:

- **Historia del sueño:** patrón horario, rutina, ambiente, consumo de sustancias.
 - **Evaluación de repercusión diurna:** fatiga, concentración, ánimo.
 - **Diario de sueño:** útil para detectar patrones irregulares.
-

4.2. Herramientas de evaluación

- **Escala de somnolencia de Epworth:** evalúa riesgo de hipersomnia (≥ 10 puntos anormal).
 - **Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (PSQI).**
 - **Cuestionario STOP-BANG:** cribado de apnea del sueño.
-

4.3. Exámenes complementarios

- **Polisomnografía nocturna:** estudio estándar para apnea, parasomnias o narcolepsia.
 - **Actigrafía:** registro de actividad motora en domicilio.
 - **Laboratorio básico:** TSH, glicemia, función hepática y renal.
-

4.4. Criterios diagnósticos (DSM-5)

Insomnio: dificultad para iniciar o mantener el sueño ≥ 3 noches por semana durante ≥ 3 meses, con repercusión diurna y sin causa médica o ambiental evidente.

Hipersomnia: somnolencia excesiva diurna ≥ 3 veces/semana durante ≥ 3 meses, no explicada por otro trastorno.

Parasomnias: conductas anormales durante el sueño, con recuerdo parcial o total, no atribuibles a sustancias o enfermedades neurológicas.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo debe ser **específico según tipo de trastorno**, priorizando **intervenciones conductuales y de higiene del sueño** antes de iniciar fármacos.

5.1. Medidas generales y de higiene del sueño

1. **Rutina regular:** acostarse y levantarse a la misma hora todos los días.
2. **Evitar estimulantes:** cafeína, nicotina, alcohol después del mediodía.
3. **Ambiente adecuado:** oscuro, silencioso, temperatura confortable.
4. **No usar pantallas antes de dormir.**
5. **Ejercicio físico diario**, pero no en las 3 h previas al sueño.
6. **No permanecer en cama despierto:** si no se concilia el sueño en 20–30 min, levantarse y hacer actividad relajante.

☐ Estas medidas son **primera línea en todos los trastornos del sueño** y deben mantenerse aunque se use farmacoterapia.

5.2. Tratamiento específico

A. Insomnio

1. Psicoterapia:

- **Terapia cognitivo-conductual para insomnio (TCC-I):**
 - Corrige pensamientos distorsionados sobre el sueño.
 - Reestructura hábitos disfuncionales.
 - Es el **tratamiento más eficaz y duradero** (MINSAL, AASM).

2. Farmacológico (solo si persiste tras TCC-I):

Fármaco	Dosis inicial	Observaciones
---------	---------------	---------------

Zolpidem	5–10 mg nocturno	Uso máximo 4 semanas; riesgo de dependencia.
Zopiclona	3,75–7,5 mg nocturno	Menor efecto residual.
Trazodona	25–100 mg nocturno	Útil en insomnio con depresión.
Mirtazapina	7,5–15 mg nocturno	Aumenta apetito; útil en depresión o caquexia.
Melatonina	1–3 mg nocturno	Eficaz en ancianos y trastornos circadianos.

□ **Evitar benzodiacepinas de larga vida media** (diazepam, clonazepam) por riesgo de caídas, dependencia y deterioro cognitivo.

B. Hipersomnia

1. **Tratar causa subyacente:** apnea, hipotiroidismo, fármacos.
2. **Higiene del sueño y evitar sedantes.**
3. **Narcolepsia:**
 - **Modafinilo 100–200 mg/día** (estimulante de vigilia).
 - Evitar uso nocturno.
4. **Apnea del sueño:**
 - **CPAP nocturno**, control de peso, suspensión de alcohol y sedantes.

C. Parasomnias

1. **Educación y seguridad:** cerrar ventanas, retirar objetos peligrosos.
2. **Evitar privación de sueño, alcohol y estrés.**

3. **Sonambulismo / terrores nocturnos:** suelen remitir espontáneamente; benzodiacepinas a bajas dosis (clonazepam 0,25–0,5 mg) solo en casos graves.
 4. **Trastorno de conducta del sueño REM:**
 - Clonazepam 0,25–1 mg nocturno o melatonina 3–6 mg.
 - Evaluar patología neurológica subyacente (Parkinson, demencia).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Fatiga crónica, irritabilidad, depresión.
- Caídas y accidentes laborales o de tránsito.
- Disminución cognitiva en adultos mayores.
- Dependencia de hipnóticos.
- Riesgo cardiovascular en apnea no tratada.

Pronóstico

- La mayoría de los casos mejora con **TCC-I y medidas conductuales**.
 - El pronóstico empeora con **uso prolongado de sedantes o comorbilidad psiquiátrica**.
 - Parasomnias tienden a remitir con la edad, excepto el **trastorno de conducta REM**, que puede ser **precursor neurodegenerativo**.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **TCC-I** es el tratamiento más eficaz y duradero para el insomnio crónico.
 2. En **depresión**, la trazodona o mirtazapina son preferibles a los hipnóticos.
 3. **Melatonina** es segura y eficaz en adultos mayores y trastornos del ritmo circadiano.
 4. La **apnea del sueño** debe sospecharse en pacientes con **ronquidos, pausas respiratorias y somnolencia diurna**.
 5. El **trastorno de conducta del sueño REM** puede ser signo precoz de **Parkinson o demencia de cuerpos de Lewy**.
 6. Evitar **benzodiacepinas prolongadas** en adultos mayores (riesgo de caídas y demencia).
 7. La **evaluación del sueño** debe incluir consumo de cafeína, fármacos y hábitos diarios.
-



Errores comunes

- Tratar el insomnio solo con fármacos, sin higiene del sueño.
 - Prescribir benzodiacepinas por meses.
 - No pesquisar apnea obstructiva antes de iniciar hipnóticos.
 - Ignorar depresión o ansiedad subyacente.
 - No diferenciar terrores nocturnos (No REM, sin recuerdo) de pesadillas (REM, con recuerdo).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **trastornos del sueño** son frecuentes y afectan la salud física y mental.
2. El **insomnio crónico** se define por dificultad ≥ 3 noches/semana por ≥ 3 meses con repercusión diurna.

3. La **Terapia Cognitivo-Conductual** y la **higiene del sueño** son el tratamiento de elección.
4. La **melatonina** es segura y útil en ancianos o jet lag.
5. En **narcolepsia**, el **modafinilo** es el fármaco de elección.
6. En **trastorno de conducta del sueño REM**, considerar **clonazepam o melatonina** y evaluar patología neurológica.
7. Evitar el uso prolongado de **benzodiacepinas**, especialmente en adultos mayores.